

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA

Documentación de Consulta — Atención Primaria

Paciente: Hombre, 71 años, 82 kg	eGFR: 58 mL/min/1,73 m ²	Fecha: 21 de marzo de 2026	Tipo de consulta: Atención primaria
---	--	-----------------------------------	--

1. NOTA DE CONSULTA CLÍNICA

Formato: SOAP | Motivo: Osteoartritis de rodilla derecha

S — SUBJETIVO

Paciente masculino de 71 años con diagnóstico establecido de osteoartritis (OA) de rodilla derecha acude a control. Refiere dolor persistente calificado en 7/10 en escala visual analógica (EVA), con impacto funcional significativo sobre la deambulación y las actividades de la vida diaria. Refiere haber completado ciclo previo de acetaminofén 1000 mg tres veces al día durante seis semanas, sin obtener alivio analgésico satisfactorio. Niega mejoría con tratamientos tópicos previamente prescritos. No reporta hematuria, melena ni síntomas neurológicos en el momento de la consulta.

O — OBJETIVO

Antecedentes patológicos relevantes:

- Fibrilación auricular no valvular (FANV) — anticoagulado con warfarina sódica, en rango terapéutico.
- Hipertensión arterial — controlada con lisinopril.
- Hipercolesterolemia — en tratamiento con atorvastatina.

Medicación actual:

- Warfarina sódica 5 mg v.o. c/24 h — INR 2,4 (verificado hace 8 días, en rango terapéutico).
- Succinato de metoprolol 50 mg v.o. c/24 h.
- Lisinopril 10 mg v.o. c/24 h.
- Atorvastatina 40 mg v.o. c/24 h.

Parámetros de laboratorio relevantes:

- Función renal: eGFR 58 mL/min/1,73 m² — corresponde a ERC estadio G3a.
- INR: 2,4 (rango terapéutico: 2,0–3,0).

A — ANÁLISIS

Osteoartritis de rodilla derecha con dolor moderado-severo (EVA 7/10) refractario a acetaminofén a dosis plenas y a tratamiento tópico previo. El cuadro genera limitación funcional significativa. Dado el perfil farmacológico del paciente (anticoagulación con warfarina, ERC G3a, IECA, betabloqueante) y el fracaso de las alternativas de primera línea, se realiza valoración individualizada del riesgo-beneficio de la adición de un AINE oral a la dosis mínima eficaz bajo vigilancia intensificada, decisión tomada conjuntamente con el paciente tras discusión extensa de los riesgos. Para la fundamentación pormenorizada del análisis riesgo-beneficio, véase el Documento 2 adjunto.

P — PLAN

Farmacológico:

- Naproxeno sódico 220 mg v.o. c/12 h, con alimentos, durante el tiempo mínimo necesario para control del dolor. Se prescribe a la dosis efectiva más baja tras fracaso documentado de alternativas.
- Se mantiene toda la medicación concomitante sin modificaciones.

No farmacológico:

- Fisioterapia: fortalecimiento del cuádriceps y ejercicio aeróbico supervisado de bajo impacto.
- Aplicación local de frío/calor según tolerancia.
- Reducción de carga articular: evitar escaleras, considerar uso de bastón si necesario.

Seguimiento:

- Control de INR en 5–7 días tras inicio del naproxeno; posteriormente según resultado.
 - Control de función renal y electrolitos a las 2 semanas.
 - Consulta de revisión en 4 semanas o antes si aparece cualquier signo de alarma.
 - Educación al paciente sobre signos de hemorragia gastrointestinal y renal (véase Documento 4).
-

2. DECLARACIÓN DE ANÁLISIS RIESGO-BENEFICIO

Prescripción: Naproxeno sódico 220 mg v.o. c/12 h en paciente anticoagulado con ERC G3a

2.1 Indicación clínica y contexto

Paciente de 71 años con OA de rodilla derecha e impacto funcional severo (EVA 7/10). Se documenta fracaso terapéutico previo con acetaminofén 1000 mg TID durante 6 semanas y con tratamientos tópicos (capsaicina y/o diclofenaco tópico), por insuficiencia analgésica. El uso de inhibidores selectivos de COX-2 fue descartado por inaccesibilidad económica del paciente. La fisioterapia está siendo considerada como medida coadyuvante pero no resuelve el dolor agudo. Ante la ausencia de alternativas analgésicas accesibles y efectivas, se valora la prescripción de naproxeno oral a dosis mínima.

2.2 Riesgos identificados y medidas de mitigación

Riesgo 1 — Interacción AINE/warfarina: incremento del riesgo hemorrágico

- Mecanismo: inhibición de COX-1 plaquetaria y posible desplazamiento proteico con elevación del INR.
- Riesgo basal aumentado por anticoagulación crónica (INR 2,4) y edad avanzada.
- Medida de mitigación: control de INR a los 5–7 días del inicio; ajuste de dosis de warfarina según resultado; instrucción al paciente sobre signos de sangrado.

Riesgo 2 — Nefrotoxicidad en contexto de ERC G3a (eGFR 58)

- Mecanismo: reducción de prostaglandinas vasodilatadoras renales, con riesgo de lesión renal aguda sobreañadida o progresión de ERC.
- Medida de mitigación: uso de la dosis mínima eficaz, control de creatinina y electrolitos a las 2 semanas, hidratación adecuada, instrucción de suspender el AINE ante deterioro renal.

Riesgo 3 — Atenuación del efecto de lisinopril y metoprolol

- Mecanismo: antagonismo prostaglandínico con posible elevación tensional y pérdida de control de frecuencia cardíaca en FA.
- Medida de mitigación: monitorización de PA y FC en la consulta de revisión; ajuste de antihipertensivos si necesario.

2.3 Beneficios esperados

- Control analgésico del dolor moderado-severo que impide la deambulación normal.
- Preservación de la funcionalidad y calidad de vida del paciente.
- Reducción del riesgo de caídas asociadas al dolor no controlado y a la marcha compensatoria.

2.4 Conclusión del análisis

Tras ponderación individualizada, se concluye que en este paciente concreto, con fracaso documentado de todas las alternativas accesibles y ante la necesidad de alivio funcional del dolor, los beneficios del tratamiento con naproxeno a la dosis mínima eficaz bajo vigilancia intensificada superan los riesgos, siempre que se cumplan estrictamente las medidas de monitorización descritas. La decisión fue tomada conjuntamente con el paciente, quien fue informado extensamente y otorgó su consentimiento (véase Documento 4).

Se revisará la continuidad del tratamiento en la consulta de seguimiento a las 4 semanas, con posibilidad de suspensión anticipada ante cualquier evento adverso.

3. PLAN DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO

Aplicable a partir del inicio de naproxeno sódico 220 mg c/12 h

3.1 Monitorización del INR y anticoagulación

Momento	Determinación	Acción según resultado
5–7 días tras inicio	INR	Ajustar warfarina si INR fuera de rango 2,0–3,0; suspender naproxeno si INR >3,5
2 semanas	INR + creatinina + potasio	Si eGFR cae >20% respecto a basal o K >5,5 mEq/L: suspender AINE y reevaluar
4 semanas (consulta)	INR + función renal + PA + FC + EVA dolor	Reevaluar continuidad del naproxeno; objetivo: dosis mínima eficaz o suspensión

3.2 Signos de alarma de hemorragia gastrointestinal

Instrucción al paciente de acudir a urgencias o contactar con el médico de forma inmediata si presenta:

- Heces de color negro o alquitranado (melena) — signo cardinal de hemorragia digestiva alta.
- Sangre roja en las heces (hematoquecia).
- Vómitos con sangre o con posos de café (hematemesis).
- Dolor epigástrico intenso o de nueva aparición.
- Mareo, debilidad súbita, síncope o palidez intensa.
- Aparición de equimosis o hematomas sin traumatismo aparente (signo de elevación del INR).

3.3 Signos de alarma de deterioro renal

- Disminución marcada de la diuresis o ausencia de orina.
- Edema en miembros inferiores de aparición o empeoramiento brusco.
- Aumento de peso superior a 2 kg en 48 horas.
- Deshidratación por fiebre, vómitos o diarrea (factor precipitante de IRA en contexto de AINE + ERC).

3.4 Criterios de suspensión inmediata del naproxeno

- INR >3,5 en cualquier determinación.
- Descenso del eGFR >20% respecto al valor basal (58 mL/min/1,73 m²).
- Cualquier signo o síntoma de hemorragia activa.
- Elevación de potasio >5,5 mEq/L.
- Pérdida de control tensional no respondedora a ajuste de medicación antihipertensiva.

4. DOCUMENTO DE ASESORAMIENTO AL PACIENTE Y REGISTRO DE CONSENTIMIENTO

4.1 Datos de identificación

Paciente: Hombre, 71 años

Fecha de la consulta: 21 de marzo de 2026

Médico responsable: [Nombre del médico — completar]

Centro de salud: [Centro — completar]

4.2 Información proporcionada al paciente

Se confirma que durante la consulta de hoy se explicó al paciente, en lenguaje comprensible y adaptado, la siguiente información:

Diagnóstico y situación clínica:

- Osteoartritis de rodilla derecha con dolor severo (7/10) que limita la marcha.
- Fracaso del tratamiento previo con paracetamol a dosis máximas durante 6 semanas.
- Fracaso de los tratamientos tópicos previamente prescritos.
- Inaccesibilidad económica a los inhibidores de COX-2 como alternativa.

Medicamento prescrito:

- Naproxeno sódico 220 mg, tomado dos veces al día con alimentos.
- Objetivo: alivio analgésico del dolor articular que impide la deambulación normal.

Riesgos específicos comunicados:

- Riesgo de sangrado aumentado: el naproxeno puede interaccionar con la warfarina y elevar la posibilidad de hemorragia, principalmente en el aparato digestivo. Se han explicado los signos de alarma (heces negras, vómitos con sangre, mareos inexplicados).
- Riesgo renal: el paciente tiene una función renal moderadamente reducida. El naproxeno puede afectar al riñón, especialmente si hay deshidratación por fiebre, diarrea o vómitos. Se le ha indicado que aumente la ingesta de líquidos y evite situaciones de deshidratación.
- Riesgo sobre la presión arterial: el naproxeno puede reducir el efecto de algunos medicamentos para la tensión arterial.

Alternativas discutidas y motivo de no adopción:

- Capsaicina tópica — probada previamente sin beneficio.
- Diclofenaco tópico — probado previamente sin beneficio.
- Inhibidores de COX-2 (celecoxib) — inaccesibles por costo económico.
- Infiltración intraarticular — valorada; derivación pendiente de respuesta del paciente.

4.3 Comprensión y decisión del paciente

El paciente demostró comprensión adecuada de la información recibida, incluyendo los riesgos y los signos de alarma. Manifestó haber sopesado los riesgos explicados frente al impacto del dolor no controlado en su calidad de vida y funcionalidad. Rechazó las alternativas propuestas por los motivos indicados y solicitó proceder con la prescripción de naproxeno bajo las condiciones de seguimiento acordadas.

4.4 Instrucciones entregadas al paciente

- Tomar el naproxeno siempre con alimentos o leche para reducir la irritación gástrica.
- No superar la dosis prescrita ni prolongar el tratamiento por su cuenta.
- No tomar conjuntamente otros AINE, aspirina ni ibuprofeno de venta libre.
- Acudir a control de INR en los próximos 5 a 7 días.
- Acudir de urgencia si aparecen heces negras, vómitos con sangre, mareos o sangrado inusual.
- Mantener una buena hidratación; avisar si presenta fiebre, vómitos o diarrea prolongada.
- Control de laboratorio programado a las 2 semanas del inicio.
- Consulta de seguimiento en 4 semanas o antes si hay deterioro.

4.5 Registro del médico responsable

Yo, abajo firmante, confirmo que:

- Revisé exhaustivamente el perfil farmacológico del paciente e identifiqué las interacciones y contraindicaciones relevantes.
- Realicé un análisis individualizado del riesgo-beneficio, documentado en el apartado correspondiente.
- Informé al paciente de forma completa, clara y comprensible sobre los riesgos, beneficios y alternativas.
- El paciente demostró comprensión y otorgó su consentimiento para proceder con el tratamiento.
- La prescripción se realizó a la dosis mínima eficaz bajo protocolo de vigilancia intensificada.

Firma y sello del médico:

Fecha:

[Nombre y n° de colegiado]

21 de marzo de 2026

Nota: Este documento forma parte de la historia clínica electrónica del paciente y tiene carácter confidencial. Su reproducción o acceso queda restringido al personal sanitario autorizado según la legislación vigente en materia de protección de datos de salud.